

Krankheit	Anamnese	Status	Prozedere / Untersuchungen	Therapie	Kommentar
Impfanamnese	Impfungen gemacht + wann welche, Kinderkrankheiten, Einstellung d. Eltern, Angst abbauen	Lymphknoten, Haut (Exanthem), Mund (Zunge, Tonsillen, Rachen), Lunge, Herz, Abdomen	Impfungen empfehlen: <u>Ab 2 Mt.</u> : Diphtherie/Tet/Polio, H. influenza, Hep. B, Pneumokokken, Keuchhusten <u>Ab 12 Mt.</u> : MMR, Meningokokken C, <u>11-15 J.</u> : Varizellen*	Kinderkrankheiten (Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Keuchhusten, Diphtherie, Scharlach, 3-T-Fieber) Impfungen : MMR, Varizellen, Tetanus/Polio/Diphtherie, Keuchhusten, H. influenzae Typ B (Grippe), Pneumokokken, Meningokokken C, *weil fast alle Kinder Varizellen durchmachen + relativ harmlos >impft mit 11-15J. nur jene, die Seronegativ sind.	
Ernährungsanamnese/Stillen	Siehe CST-ZF + Prakti-ZF				
Entwicklung	Siehe CST-ZF				
Status GEBS (Frischgeborener)	Vorkehrungen : Wärmebett mit Wärmelampe, O2, Tücher, etc.	Nach Geburt sofort : In warmes Tuch hüllen + trocknen, Bett/Wärmelampe, APGAR, Pulse + Rekap, Präkordium, Herz-Lunge, Abdomen inkl. Darmgeräusche	Biox, BE (Nabel-pH, Blutgase) Den Eltern geben Geburtszeit erfassen		
Neugeborenenstatus/ Wochenbett (3. Tag i.d.R.)	JL, AZ (Verhalten, Weinen, Spielen, Schreien, Trinken, Essen, Ausscheidung, Apathie, schläfrig), B-Symptome Schwangerschaft -Anamnese Geburts -Anamnese Ernährung, Stillen Impfungen PA, FA, Allergien, Medis, Soziales	Perzentilen (KU, Gewicht, Grösse), Inspektion (Reifezeichen, Zyanose, Dysmorphie-Zeichen, Haut), Herz (Präkordium, Schwirren, Auskult. Inkl. Carotis, Pulse ingual + brachial, Rekap.), Lunge (Atemnotzeichen, Auskult.), Abdomen (Palpation, DG's, Milz, Leber), Neuro (Hand- + Fussgreifreflex, Saugreflex, Schreitreflex, Moro, M-Tonus), Bewegungsapp. (Tonus, Gelenke bewegen, alle Knochen da? Wirbel?), Kopf (Lid-, Gaumenspalte, Fontanellen, Ohren, Augen inkl. Fundoskopie), Genitale (Hoden-Deszension), Bauchlage (Nieren, WS, Spina bifida, Anus)	OAE Schädel + Becken-US BE/Guthrie-Screening Vit. D + Vit. K Stillberatung anbieten Pädiater organisieren	Reifezeichen : Lanugo-Haare nur an Schulter + Oberarmen, subkutanes Fett, Nägel überragen Fingerkuppen, Gefaltete Fusssohlen, Grosse Schamlippen überdecken Kleine, Hoden-Deszensus, >48 cm, >2500g, Nasen- + Ohrenknorpel Atemnotzeichen : Einziehungen, Tachypnoe, Nasenflügeln, Stöhnen, Stridor, Giemen, Zyanose SS- + Geburtsanamnese: s. unten	
Untersuchung Säugling	JL, AZ (Verhalten, Weinen, Spielen, Schreien, Trinken, Essen, Ausscheidung, Apathie, schläfrig), B-Symptome Schwangerschaft -Anamnese Geburts -Anamnese Ernährung, Stillen Impfungen PA, FA, Allergien, Medis, Soziales	Perzentilen (KU, Gewicht, Grösse), Inspektion (Reifezeichen, Zyanose, Dysmorphie-Zeichen, Haut), Herz (Präkordium, Schwirren, Auskult. Inkl. Carotis, Pulse ingual + brachial, Rekap.), Lunge (Atemnotzeichen, Auskult.), Abdomen (Palpation, DG's, Milz, Leber), Neuro (NG-Reflexe noch da? M-Tonus, Sens., BSR-, PSR-Reflex), Bewegungsapp. (Tonus, Gelenke bewegen), Kopf (Fontanellen, Ohren, Augen inkl. Fundoskopie), Genitale (Hoden-Deszension), Bauchlage (Nieren, WS)			SS- + Geburtsanamnese: s. unten Siehe CST-ZF

Siehe CST-ZF	Untersuchung Kleinkind Anamnese: <u>AZ</u> (Spielen, Schreien, Trinken, Urin, Stuhl, Schlaf, etc.), <u>Perzentilen</u> , Ernährung, <u>Impfungen/Kinderkrankheiten</u> , Schlaf, B-Symptome, <u>Entwicklung</u> (Sprache, Fremdeln, Motorik, Zähne, Kognition) + Schulanamnese PA, FA, Allergien, Medis, Soziales Internistischer Status: <u>Perzentilen</u> (Gew., Grösse, KU), Inspektion, Kardiostatus, Pneumostatus, Abdomen, Neurostatus, HNO (Otoskopie, Gehör, Rachen, Mund, Nase, Hals), Bewegungsapparat, LK + SD		Untersuchung Jugendlicher Anamnese: JL, <u>Perzentilen</u> , Ernährung, <u>Impfungen/Kinderkrankheiten</u> , Schlaf, B-Symptome, Wachstum + Entwicklung (Sprache, Fremdeln, Kognition) + Schulanamnese, <u>Sexualität</u> PA, FA, Allergien, Medis, Soziales Intersitischer Status: <u>Perzentilen</u> (Gew., Grösse, KU), Inspektion > <u>Tannerstadien/Sek. Geschlechtsmerkmale</u> ! Kardiostatus, Pneumostatus, Abdomen, Neurostatus, HNO (Otoskopie, Gehör, Rachen, Mund, Nase, Hals), Bewegungsapparat, LK + SD		Dysmorphiestatus Tiefsitzende Ohren, grosse Zunge, Behaarung Gesicht/Körper, zu viele od. zu wenig Finger/Zehen, Hyperakt. Präkordium, Hypertelorismus, Epikanthus, 4-Finger-Furche, plumpe Finger Sek.Geschlechtsmkmale: Schambehaarung, Achseln, Muskelaufbau M: Penis- + Hodenvergrösserung, Stimmbruch F: Labienvergrösserung, Mamma-Bildung, Menarche
Frühgeburtlichkeit	AZ Kind (Atmung, Schlaf, Schreien, Trinken, Urin, Stuhl...) Geburts-Anamnese (SAFT, Entbindungsart, APGAR) SS-Anamnese (Lungenreifung, RF's) Gefahren: Lunge: ANS, Broncho-pulm. Dysplasie ZNS: Blutungen, Bradyk-Apn.-Sy, Cerebralparese, ADHS, visuelle + aud. Störungen, Kongition, Motorik GIT: NEC/Ileus Infekte:	Perzentilen Inspektion: Ikterus, Reifezeichen Lunge: Atemnot-Zeichen Restl. Status: s. CST + oben	Biox, aBGA Exkurs: Neugeborenenikterus Dx via Coombstest (AK gg. Rh+ v. Kind), Phototherapie, AK (falls nicht genug), Austauschtransfusion (wenn s. starker Ikterus), Stillpause nicht indiziert, physiolog. Ikterus beginnt frühestens 24h postpartal und dauert max. 8-14 T. und nicht mehr als 250 mikromol/l	Pränatal: Tokolyse, B-Mimetika, Ca-Blocker, Magnesium, Lungenreifung (Cortison) Postpartal: Vitamine, Steroide, Inhalationen,	SS-Anamnese: SAFT, Alter Mutter, Anzahl Kinder, Wunschkind? Alk, Rauchen, Drogen, Erkrankungen, Medis, Soziales, Partner, Dauer SS).... Geburts-Anamnese: SAFT,Entbindugsart, Kindsmasse, APGAR, Fruchtwasserfarbe, BG.... Auslöser: Stress, Armut, <16J., Infekte, Anämie, Süchte/Drogen, Unterernährung, Vorz. Blasensprung, Plazentainsuff., Mehrlinge, Fehlbildungen...
Fieber	Tachykardie, Husten, Halsweh, Schnupfen, Kopf-Sz., Bauchweh, Erbrechen, Diarrhoe, Dysurie, Ohren-Sz., Athritis, Tagesschwankungen, Messmethode, Exanthem, Juckreiz, AZ/Verhalten, Schlaf, Kranke in Fam./Umfeld, Urin/Stuhl, Appetit, Medis, Kinderkrankheiten	Neuro: Meningismus prüfen (Nackensteifigkeit, Kernig/Lasegue-mässig), Pupillen, Sens., Hirnnerven AZ: Peripherie warm? Farbe, Turgor/Schleimhäute, Verhalten HNO (Mundhöhle, Rachen, Ohr), Lunge Haut (Exanthem) GIT/Abdomen Nierenlogon Lymphknoten Gelenke	Vitalparameter (Puls, BD, Peripherie), Fiebertemperaturen U-Status + Urikult (bei HWI + Bauchorgane) NPS, Rachenabstrich, Streptotest , bei V.a. auf Infekt obere Atemwege BE (CRP, LK, + je nach Verdacht) LP bei V.a. auf Meningitis Ev. Bildgebung (US bei inneren Organen, CT bei Mastoiditis, Rx bei Pneumonie, Szintih bei Osteomyelitis)	Fiebersenkende Medis Th. je nach Ursache Genug Trinken Sepsis-Workup wenn: akut hohes Fieber + kein Infektfokus + ev. schlechter AZ >BE (CRP, Blutbild), Blutkultur, Th-Rx*, U-Status, LP* *nur wenn schlechter AZ	DD: Infekt obere Atemwege, Fieberkrampf, Kinderkrankheiten, Tage-Fieber, Pneumonie, Gastro-E./GIT, HWI, O. media/Mastoiditis, Osteomyelitis, Meningitis, Sepsis.... Status febrilis: >7 T. NPS: eher f. Viren, Rachenabstrich (bakt.), Streptoest (Strep. A) 3-T-Fieber: meist zw. 6-24 Mt., Herpes-Virus, nach 3T. Fieber Exanthem, selbstlimitierend, sympt. Th.

Kinderkrankheiten	Impfungen, welche Kinderkrankheiten durchgemacht? Fieber, Exanthem (Details erfragen), Juckreiz, AZ, Ernährung/Appetit, Diarrhoe, Erbrechen, Kopf-Sz., Arthralgie, Bauch-Sz.	Haut + Schleimhäute + Kopf/Gesicht Lymphknoten Abdomen Mund/Rachen/Tonsillen Gelenke <u>Koplik-Flecken</u>: rötli. Punkte Wangeninnenseite <u>Achtung</u> auch <u>Exanthem</u> bei: Parvovirus B19, Entero- + Adenoviren, HHV-6 Kawasaki-Sy: whschl. infektiöse Ursache >akute Vaskulitis mittlerer Arterien <u>Diagnostik</u> i.d.R. Klinisch! Selten Serologie.	Masern-Virus: <u>Prodromi</u> (Fieber, Husten, RS, ev. <u>Koplikflecken</u>!...) dann <u>MPE</u> (konfluierend, Beginn Gesicht, Verlauf nach distal), <u>Komplik.</u> <u>ZNS</u>, <u>Pneumonie</u> u.a.; ev. Serologie (IgM), NPS, Rachenabstrich; <u>symptomat.</u> ><u>Vit.</u> <u>A</u> falls <u>Mangel</u>, <u>Ribavirin</u> falls <u>ZNS-Komplik.</u> Röteln-Virus: ev. leichte Prodromi, <u>Exanthem</u> (initial Gesicht + dann distal, <u>feinmakulös</u>, ev. Juckreiz), LK, Arthralgie; Komplik. nur wenn <u>kongenital/SS</u>; ev. Serologie (IgM), <u>symptomatisch</u> Ringelröteln-Virus: Exanthen (<u>Ohrfeigengesicht</u> + v.a. Extremitäten, <u>girlandenförmig/retikulär</u>, stärker bei <u>Stress/Sport/Emotion/Wärme</u>), Arthralgien, Komplik. falls <u>Primoinfektion in SS</u>; Serologie, PCR; <u>symptomatische</u> Th. Varizellen VZV: <u>Prodromi</u>, Fieber, <u>MPE</u> (Beginn <u>Kopfhaut</u> >Stamm >Extremitäten + Schleimhaut, Vessikel ><u>Krusten</u>), <u>Juckreiz</u>; klin. Dx od. Bläschen-Abstrich; Komplikationen ><u>bakt. Superinfektion</u>, <u>H. Zoster</u>; <u>sympt. Th.</u>, <u>Aciclovir</u> nur wenn <u>H. Zoster im Gesicht od. Immunsuppr. Od. Kind >12J./Erw.</u> Scharlach-Strep. A: <u>Streptokokken-Angina</u> (schlagartiger Beginn, hoch Fieber, Kopf- + Bauch-Sz., Erbrechen/Übelkeit, LK, <u>KEINE</u> grippalen Prodromi, geröteter Pharynx, Himbeer-Zunge, geschwollene Tonsillen, Petechien am weichen Gaumen), <u>Exanthem</u> (<u>feinpapulös</u>/Schmirgelpapier, initial Gesicht, v.a. Beugefalten, Schuppen in 2. Woche, <u>Mund-3-Eck ausgespart</u>); Komplik. ><u>Peritonsillarabszess</u>, <u>rheumat. Fieber</u>, <u>GN</u>; Strepto-Test; <u>orale AB</u>. 3-Tage-Fieber-HHV-6: hoch Fieber, Fieberkrämpfe z.T., <u>flüchtiges stammbetontes Exanthem nach Fieberabfall</u> (MPE), LK, fast nur Kleinkinder (<u>6-48 Mt.</u>); Klinik, selten Serologie; <u>symptomatisch</u> Kawasaki-Syndrom: Fieber (>5T.) + konjunkt. Inj., Exanthem, Veränderungen Lippen/Mundmukosa, LK, Extremitätenschwellungen; klinische Dx (<u>Symptomkomplex</u>); <u>hochdosiert AK i.v.</u>		
HWI	Fieber, Sz./Brennen beim Wasserlösen, häufiges Wasserlösen, Urin-Farbe, Blut, Menge, Trübung, Trinken, AZ, Intimpflege, Trinkverhalten, Opstipation Darm, wie oft Pinkeln	AZ (Turgor/Schleimhäute) Abdomen (Palpation, Auskultation, Leber, Milz) Nierenloggen Genitale Lymphknoten	U-Status (mit Sediment >EC, LK, Bakt.) + Urikult BE(CRP, LK, Kreatinin) US (immer) MCUG (nach Infekt): falls <3J. od. wenn >3J. und auffälliger US od. rezidiv. HWI's (mit Pyelonephritis).	AB (<6Mt. i.v., >6 Mt. p.o. möglich; 10-14T. ca.) Viel Trinken!	U-Status: EC's, LK, Bakterien, Nitrit im Sediment. Ideal Mittelstrahlurin, sonst Säckli-Urin. Pyelonephritis: CRP hoch, Flanken-Sz.
Husten / Infekt obere Atemwege	Trocken, Feucht, Sz., Auswurf, bellend, Schnupfen, Halsweh, Ohrenweh, Fieber, AZ, Kopf-Sz. (beim Bücken), NAB/Dyspnoe, Hyposmie, Allergien	Lunge: Auskult. + Perkussion HNO: Ohren, Nase, Rachen/Mund/Zunge Lymphknoten Haut (Exanthem)	BE (CRP + LK) <u>Schnupfen</u> NPS <u>Angina/Tonsillitis</u> od. Pharyngitis Abstrich + Streptotest <u>Mononukleose</u> BE (Leberwerte + LZ), Serologie (IgM) <u>Scharlach</u>: Streptotest Bei RS keine BE nötig, fast immer viral	<u>CRP + LK normal >viral od. Mononukleose >symptomatische Therapie</u> - Husten: Sirup (Solmucalm) - Halsweh: Lutschtabletten, Spray, Gurgeln - Schnupfen: Otrivin, Steroidspray, NaCl-Spülungen - Generell: NSAR - Allergisch: top. Steroide od. top. Antihistaminikum <u>CRP + LK hoch >bakteriell od. wenn Streptotest positiv</u> - AB + sympt. Th.	

Asthma	<u>Anfälle, Husten, Dyspnoe, Pfeiffen/Giemen</u>, Sz., Sekret, bei Belastung, saisonal/Frühlung od. perennial, top. Veranlagung (Allergien, Konjunktivitis, Rhinosinusitis, Neurodermitis), FA Trigger: Belastung, Infekte, Allergien, Medis, tox. Stoffe, kalte Luft	Lunge (Auskultation) >verlängertes Exspirium/Giemen, ev. trockene RG's, Perkussion >hypersonor, Atemnotzeichen, Freq., Herz (Tachyk., pulsus Paradoxus) HNO LK	LUFU (FEV1 + VC tief) Ev. Labor (Eosinophilie) Instruktion: Inhalationsinstruktion Peak-Flow Allerg. Abklärung bei Verdacht	1. Peak-Flow-Protokoll 2. Allergietests/Karenz 3. Ventolin mitgeben f. Anfälle 4. Simbicort (Steroid + B2-Mim. als Lanzeit-Th.) 5. bei rezidiv. Resp. Infekten Impfungen (Pneumok. + H. infl.) + Bronchovaxom	Reversibilität prüfen?
Bauch-Sz./akutes Abdomen	Schmerzen (7 Dimensionen genau erfragen, Sz/Erleichterung bei Stuhlgang, etc.), AZ, Schonhaltung, Schlaf, Fieber, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, Wind, Blähung, Stuhl- + Urin, Blutverluste, Appetit, Ernährung, Kopf-Sz., Schwindel, Arthritis, Gewichtsverlust, nächtliches Erwachen, B-Symptome, Wachstumsrückstand Trigger: Trauma, Medis, Kinderkrankheiten, Umfeld krank, Psyche/Soziales/Schule, Verdorbene Speisen	Inspektion (Kolorit, Ikterus, Blass, Turgor) + Haut + AZ + EZ, Perzentilen Abdomen (Quadranten, Auskultation, Loslass-Sz., Meteorismus, Resistenzen, Bruchpforten, Abwehrspannung Lanz/Mc Burney, Courvoisier/Murphy, Leber, Milz, Nieren) Herz, Lunge Nieren Mund Lymphknoten Analinspektion	Schmerzskala (Smileys) PVK + Labor (Hämat., CRP, LK, Hämat., Pankreas-Amylase + -lipase, Bilirubin, ALP, γ-GT, Kreatinin, Tropoin, CK-MB) US, EKG, Rx-Leer (stehend od. li-Seitenlage), Thorax (ap stehend) Ev. CT	Säuglingskolliken: Info dass harmlos, ev. Time-Out, Bauchmassage, Fencheltee Unklare Ursache: Verlaufsbeobachtung + Schmerzprotokoll, ev. Ernährungsberatung 80% der Bauch-Sz. bei Kindern funktionell!!!	<u>3-Monats-Kolliken</u> (>3h/T. an >3T./Wo + mind. 3 Wo., harmlos, verschwinden nach 3. Mt. meist) <u>GIT</u> (Invagination, GERD, Hernie, Fremdkörper, Zöliakie, Obstipation, Appendizitis, M. Crohn, etc.) <u>Funktionell</u>, wenn >12 Wo. redivi. Sz. + kein ZH mit Nahrungsaufnahme/Defäkation, Sz. n. zunehmend; Je näher am Nabel, kaum nachts, diffus, Schilderung komisch; Ängste, Stress, Motilitätsstörung, Hypersensitivität, E., Hormone) <u>Infekt</u> (HWI, Meningitis, O. media...) <u>Urogenitaltrakt</u>: Pyelonephritis, Torsion, Orchitis, Zysten..... <u>Bewegungsapparat, Herz-Lunge</u>.
Gastroenteritis	Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe (Blut, Schleim, Farbe, Menge, Konsistenz, Freq.), Fieber, Kopf-Sz., AZ, Bewusstsein, Krämpfe, Ernährung/Trinken, Stuhl + Urin, Umfeld, verdorbene Speisen, Einfuhr vs. Verluste berechnen, Auslandsreisen *Erlittene Verluste (inner 4h mit Oraler Hydratationslösung ersetzen), laufende Verluste + Erhaltungsbedarf!	Inspektion (Kolorit, Ikterus, Blass, Turgor/Schleimhäute/ Fontanellen, Bewusstsein) Abdomen (Quadranten, Auskultation, Loslass-Sz., Meteorismus, Resistenzen) Lymphknoten Herz, Lunge Nieren Mund	Monitoring: Atmung, BD, Puls, Bewusstsein Urin/Stuhl in Windeln ansehen Fieber + Gewicht messen <u>Andauernder schwerer GE:</u> Labor (Elektrolyte, Glucose, Laktat, Blutbild, CRP), Urinstatus Erreger-Dx (Stuhlkulturen, Serologien)	1. *Hydratation (Tee + Sirup in kl. Mengen), orale Elektrolyte/Hydratationslösung (4h) 2. Nur kurz Schonkost, schnell wieder normale Nahrung! 3. Antiemetikum/Motilium 4. Immodium (nur wenn dringend nötig >Reisen, Arbeit) 6. Buscopan (wenn Krämpfe) 5. Bioflorin für nach GE Wenn Exsikkose/stark red. AZ >Hospitalisation + i.v. NaCl, i.d.R. keine Indikation f. AB, ausser: blutige Durchfälle, hohes Fieber, Säugling, Alte >Ciprofloxacin	Melden falls Problem mit Hydratation! Dauert 5-7 T., s. ansteckend oft. Schonkost nicht lange! Meist viral, wenn bakt. dann oft hoch Fieber + blutiger Durchfall. Orale Hydratationslösung: H2O + Elektrolyte + Glucose, nur f. die ersten Stunden, dann wieder Shoppen/normale Kost! Stillen nicht unterbrechen.
Otitis media	s. ORL-ZF				
Verschluckter FK	Siehe ORL				

Epiglottitis/Pseudokrupp	Epiglottitis: Hals-Sz., Fieber, kein Husten i.d.R., Stertor, Atemnot, Speichelfluss, klossige Sprache Krupp-Syndrom: Atemnot, inspirat. Stridor, Heiserkeit, bellender Husten, ev. Fieber, ev. Erkältungszeichen	Atemnotzeichen: Einziehungen, Tachypnoe, Nasenflügeln, Stöhnen, Stridor, Zyanose Obstruktionszeichen: verlängertes Inspirium, Stridor, Tachykardie, Hypertonie, Schwitzen, Unruhe, paradoxer Puls Lebensgefahr: Zyanose, Krämpfe, Bewusstseinsstörung, Bradypnoe, Bradykardie, Silent Chest	Erstversorgung akute Atemnot Tender loving Care, O₂, Absaugen, Maskenbeatmung, ev. Intubation, Laryngoskopie (in Sedation!), ev. AB Epiglottitis Racheninspektion in Inhalationsnarkose, Intubation + Befeuchtung, AB Pseudo-Krupp 1. Adrenalin-Inhalation, Steroide, selten Intub., AB (falls bakt. Laryngotracheitis)	DD: Asthma, Bronchiolitis >verlängertes Inspirium Echter Krupp: Diphtherie, selten Pseudo-Krupp: viral (Zeichen d. Erkältung), allergisch/spasmisch (dramatisch, meist nachts aus völliger Gesundheit), bakterielle Laryngotracheitis (Erkältung mit Superinfektion durch Bakt., hohes Fieber)
Epilepsie / Fieberkrampf	Klass. Epi: Wann 1. Anfall, Dauer, Zungenbiss, Einnässen/Einkoten, Krämpfe (alle Extremitäten?), Bewusstseinsverlust, Augen, postiktale Phase, FA, Medis Fieberkrampf: Fieber, Kopf-sz., Infekt Affektkrampf: Sz./Wut/Trotz >Schreien, Zyanose, Apnoe, dann tonische od. schlaffe Stellung Weisser Affektkrampf: Sz. od. unangenehme Empfindung >meist kein Schreien >Blässe, Versteifung, Kloni, Asystolie, ev. Urinabgang BNS: Syndrom, chron. Erkrankung >Blitz, Nick, Salaam, oft beim Erwachen, dann Weinen, Entwicklungsrückschritt	Inspektion, AZ Neurostatus <u>Falls EPI-Ursache nicht klar:</u> im Notfall wie klass. Epi behandeln und dann Ursache suchen: Anamnese Eltern (Trigger, Infekt, chron. Krankheit...), Fieber messen, BE (Infektparameter, Elektrolyte, etc.), Glucose, ev. LP, CT (wenn persist. Bewusstseinsstörung), selten EEG (BNS)	ABC machen! O₂ geben + Fieber messen: falls >38° >Fieberkrampf od. Meningitis, sonst Epi, Monitoring, Seiten- od. Bauchlage (Aspiration) <u>Klass. Epi (ohne Fieber) od. St. epilepticus</u> Sofort: Benzos (rectal) + O₂, ev. Dormicum (oral) PVK (Ringer od. NaCl + Temesta) + BE (Na, Ca, Mg), Glucose, Wenn Krampf persistiert od. wieder: Phenytoin od. Phenobarbital <u>Fieberkrampf (DD Meningitis)</u> BE (Elektrolyte), Glucose, falls 1.mals keine antikonvul. Th.nötig (Reserve mitgeben), sonst Diazepam (rectal), ev. Antipyretika >Fieberfokus suchen >LP (falls Fieber + kein Infektfokus od. schlechter AZ (Ausschluss Mening.)) <u>Affektkrampf:</u> O₂, keine Antikonvulsiv >Fe-Substitution, Trigger beheben <u>Weisser Affektkrampf:</u> EKG, Kreislauf stabilisieren, O₂, Adrenalin ev. BNS: EEG, Vit.B6, Vigabatrin, ev. ACTH od. Antiepil., MRI-Schädel, Stoffwechsel-Screening EEG (nicht im Akutstadium, ausser V.a. BNS-Epi)	Fieberkrampf: Epi bei Infekt i.R. Fieber ausserhalb ZNS. Antikonvulsive Th. nach einmaligem Fieberkrampf nicht indiziert. Reserve mitgeben (Rektien + Antipyretika) Affektkrampf ist kein Epi, Trigger durch Sz./Wut/Trotz Weisser Affektkrampf: Sz. od. unangenehme Empfindung als Trigger für vagale Dysregulation BNS-Epi: meist i.R: sympatoma. Neurolog. Störung, chron. Erkrankungen, Missbildungen
Gedeihstörung	Geburts- + SS-Anamnese, Entwicklung, Sport, Schule, Ernährungsanamnese, Appetit, Husten, Gewichtsverlust, B-Symptome, Schmerzen, Verdauung, Grösse d. Eltern, adoptiert/leiblich, genet. Erkrankungen in Fam., Medis/Steroide, SD-Probleme, Geburtsgrösse, chron. Erkrankungen, Zöliakie, Psycho-Soziales ZF: chron. Husten, Sinusitis, Giemen, Polypen, ANS, Atemwegsinfekte, Verdauungsprobleme, Wachstumsrückstand, DM, Schlafstörungen, Bauch-Sz., Obstipation	Perzentilen (Kriterien: unter 3. P. od. ober 97. P. od. Abweichung v. mind. 2 SD v. Zielgrösse) Internistischer Status (Giemen, Atemnotzeichen, ev. Lungengeräusche, Clubbing d. Finger + Zehennägel, geblähtes Abdomen, Polyposis nasi, Hautprobleme, etc.) Dysmorphie-Zeichen Hautfaltenmessung	BE (WH, SD-Hormone, Cortisol, Glucose, Calcium, P, Hämatologie, Pankreaswerte, Proteine, Fe, Folsäure, B12, etc.) Urinstatus Genanalyse ev. Fettbilanz (Stuhl 72h) ev. Funktionstests/Neurologie/Psych. CF: Schweisstest, LUFU, Elastase-Bestimmung (Stuhl >Pankreasinsuff.), Vitaminspiegel Serum, ev. Molekulargenet. Tests CF: Pankreasenzymersatz, Vitamine, Kalorien + Proteine, Kochsalz, Urodesycholsäure, B2-Mimetika, O₂-Therapie, Inhalationen, Physio/Atemübungen, Impfungen, AB, orale Steroide, Ibuprofen, ATP + UPT inhalativ, Lungenresktion, Polypenresektion, OLT, etc.	Husten + Geideihstörung: ZF CF-Probleme: Pankreas, Lunge, GIT Ursachen: Zystische Fibrose, Ehler-stanlos-Sy., Marfan-Sy., Chondrodysplasie, Rachitis, Syndrome/Genetik, Marasmus, Kwashiokor, Psycho-Sozial, Zöliakie, Pankreasinsuffizienz, konstitutionell, Endokrinopathie, Malignom, erhöhter Energiebedarf, CED, Vernachlässigung/Misshandlung

!!!NICHT VERGESSEN: PA (SS- + Geburtsanamnese), FA, Medis, Allergien, Soziales/Entwicklung. Genauer Status + Anamnese siehe CST.